

A Reforma Obstétrica no Brasil

Luciane da Silva D'Avila · SIAPARTO · São Paulo / SP · 2025

Resumo Executivo

A palestra de Luciane da Silva D'Avila, Presidente da ABENFO Nacional, apresenta uma proposta urgente: a Reforma Obstétrica no Brasil. A tese central é que o modelo brasileiro de atenção ao parto está em crise — somos vice-campeões mundiais de cesariana, com taxas em torno de 59%, e ainda registramos índices alarmantes de mortalidade materna e neonatal, especialmente entre mulheres negras.

Iniciativas anteriores como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM, 2004), a Rede Cegonha (2011) e a recente Rede Alyne (2024) trouxeram avanços, mas não conseguiram mudar os indicadores principais. Segundo a OMS, o motivo é claro: para mudar resultados, é preciso mudar quem lidera o cuidado.

A proposta é colocar enfermeiras obstétricas e obstetrizas na liderança da atenção ao parto de risco habitual, em colaboração com médicos. Países como Nova Zelândia, Senegal e Uganda já fazem isso, com bons resultados. A OMS estima que essa mudança poderia salvar até 4,3 milhões de vidas por ano no mundo.

Sobre a Palestrante

Luciane da Silva D'Avila é enfermeira obstétrica de Santa Catarina e Presidente da ABENFO Nacional. Integra a Comissão de Parto Domiciliar Planejado da ABENFO-SC e tem trajetória de defesa de políticas públicas de saúde da mulher. Como Presidente da entidade nacional da categoria, está na linha de frente da articulação política da Reforma Obstétrica, incluindo a entrega do Manifesto pela Reforma Obstétrica ao Ministério da Saúde em 2025 e a interlocução com o Conselho Nacional de Saúde.

Saiba mais: abenfo.org.br

A Reforma Obstétrica no Brasil

Luciane da Silva D'Avila · SIAPARTO · São Paulo / SP · 2025

Linha do Tempo

Marcos principais da história da enfermagem obstétrica brasileira:

- **1988** — Constituição Federal cria o SUS.
- **1992** — Fundação da ABENFO.
- **2004** — Lançamento da PNAISM (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher).
- **2011** — Criação da Rede Cegonha — primeira política a reconhecer formalmente o protagonismo das enfermeiras obstétricas.
- **2014** — Pesquisa "Nascer no Brasil" (Fiocruz) revela violência obstétrica e excesso de cesarianas.
- **2024** — OMS lança o "Modelo de Transição Obstétrica". Brasil relança a Rede Cegonha como Rede Alyne.
- **2025** — Manifesto pela Reforma Obstétrica entregue ao Ministério da Saúde.

Tópicos Principais

Cinco ideias-chave para entender a Reforma Obstétrica.

1. O que é a Reforma Obstétrica

A Reforma Obstétrica é uma proposta de mudança profunda no modelo brasileiro de atenção ao parto, inspirada na Reforma Psiquiátrica das décadas de 1980-1990. A ideia central é mudar quem lidera o cuidado: passar do modelo médico-centrado e hospitalocêntrico para um modelo onde enfermeiras obstétricas e obstetrizas coordenam o cuidado nos partos de risco habitual, em colaboração com outros profissionais.

Aplicação prática:

Em estágios e atividades práticas, observe quem decide o que durante o atendimento. A mulher é consultada antes das intervenções? As boas práticas são seguidas?

2. Os Números do Problema

Os indicadores brasileiros são preocupantes em três frentes: cesarianas em excesso, mortalidade materna alta (especialmente entre mulheres negras) e cobertura insuficiente de cuidados pré-natais.

A Reforma Obstétrica no Brasil

Luciane da Silva D'Avila · SIAPARTO · São Paulo / SP · 2025

Indicador	Brasil
Taxa de cesarianas	~59% (vice-campeão mundial; OMS recomenda 10-15%)
Partos de risco habitual	~85% (segundo a OMS)
Gestações não planejadas em mulheres negras	~74%
Adequação pré-natal em mulheres negras	~8% — desigualdade racial gritante
Métodos contraceptivos de longa duração	~2% — muito abaixo da Europa

Aplicação prática:

Esses dados são prova pública e aparecem em concursos, residências e provas. Mais importante: representam pessoas e desigualdades reais.

3. Por Que as Políticas Anteriores Não Bastaram

PNAISM, Rede Cegonha e Rede Alyne trouxeram avanços, mas não moveram indicadores principais. O motivo, segundo a palestrante: nenhuma alterou a estrutura central de quem coordena o cuidado. Programas mudam, mas se a lógica de coordenação não muda, os resultados resistem.

Aplicação prática:

Em provas que perguntam "por que o SUS não conseguiu reduzir mortalidade materna?", uma resposta forte foca no modelo de organização do cuidado — não em "falta de verba".

4. A Proposta — Liderança da Enfermagem Obstétrica

A proposta é colocar enfermeiras obstétricas e obstetrizes na liderança do cuidado obstétrico de risco habitual, com colaboração de médicos, doulas, fisioterapeutas e psicólogos. Não é "tirar o médico" — é redistribuir papéis pela competência específica.

A Reforma Obstétrica no Brasil

Luciane da Silva D'Avila · SIAPARTO · São Paulo / SP · 2025

Dado-chave

Um aumento de 10% nas intervenções por enfermeiras obstétricas (com autonomia plena) pode evitar:

- 23% das mortes maternas e neonatais por ano
- 14% dos natimortos por ano
- Globalmente, até 4,3 milhões de vidas por ano até 2035

Aplicação prática:

Para estudantes de enfermagem, a reforma significa potencial de mais protagonismo profissional. Para outras áreas, é exemplo de trabalho em equipe interdisciplinar real.

5. Modelos Internacionais como Inspiração

A OMS apresenta cinco modelos:

- **Nova Zelândia:** continuidade de cuidado. Gestante escolhe equipe, que acompanha toda a jornada (24/7).
- **Senegal:** cuidado de base comunitária. Profissional itinerante visita comunidades.
- **Centros de Parto Normal:** modelo já existente no Brasil (referência: Sofia Feldman, Belo Horizonte).
- **Uganda:** maternidades privadas custeadas pelo sistema público.
- **Cenário humanitário:** modelo emergente (importante após enchentes do RS em 2024).

O denominador comum:

Todos os modelos bem-sucedidos são coordenados por enfermeiras obstétricas e obstetrites, com colaboração interdisciplinar.

Aplicação prática:

O Brasil precisará adaptar regionalmente. Pensar como aplicar esses modelos a uma comunidade específica é excelente exercício acadêmico.

A Reforma Obstétrica no Brasil

Luciane da Silva D'Avila · SIAPARTO · São Paulo / SP · 2025

Mapa de Conexões

Como este tema se conecta a outras disciplinas que você possivelmente estuda:

- **Saúde Coletiva:** políticas públicas, SUS, redes de atenção.
- **Direitos Humanos:** violência obstétrica, caso Alyne Pimentel na ONU.
- **Estudos Étnico-Raciais:** desigualdade racial estrutural na saúde da mulher.
- **Estudos de Gênero:** medicalização do corpo feminino, autonomia.
- **Sociologia:** profissões em saúde, poder, instituições.
- **Direito:** Lei do Acompanhante, direitos reprodutivos.
- **Economia da Saúde:** custo das cesarianas em excesso, financiamento do SUS.

Destaques

As frases mais marcantes da palestra:

💡 **"Não haverá mudança substancial na sobrevivência e experiência positiva no parto sem mudança do modelo obstétrico, com condução pela enfermagem obstétrica e pelas obstetrizes."**

Tese central da palestra, atribuída à OMS.

💡 **"Não tem rede cegonha que dê conta, não tem rede alyne que dê conta, se de fato a gente não mexer naquilo que é mais importante."**

O momento mais contundente — frustração com políticas que não tocam no cerne.

💡 **"Investir no acesso universal ao cuidado obstétrico de qualidade realizado por enfermeiras obstetras e obstetrizes pode, até 2035, salvar 4,3 milhões de vidas todos os anos no mundo."**

Dado da OMS — escala global do impacto potencial.

A Reforma Obstétrica no Brasil

Luciane da Silva D'Avila · SIAPARTO · São Paulo / SP · 2025

Conclusões

Lições Aprendidas

- Mudanças de programa não bastam — sem mudar quem coordena, indicadores não mudam.
- A Reforma Obstétrica é tecnicamente sustentada pela OMS e por evidências robustas.
- A desigualdade racial está estruturalmente presente nos indicadores brasileiros.
- Existem múltiplos modelos viáveis. O Brasil precisará adaptar regionalmente.

Próximos Passos

- Assinar o Manifesto pela Reforma Obstétrica (busque pela ABENFO).
- Acompanhar a ABENFO Nacional e a seccional do seu estado.
- Em estágios, observar criticamente a aplicação das boas práticas.
- Considerar especialização em Enfermagem Obstétrica como caminho profissional.

Trilha de Aprofundamento

- **Iniciante:** Cartilha "Boas Práticas de Atenção ao Parto" (Ministério da Saúde / Fiocruz).
- **Intermediário:** Pesquisa "Nascer no Brasil" — Fiocruz, com seus relatórios temáticos.
- **Avançado:** Lancet Series on Midwifery (2014) — série da revista The Lancet sobre o impacto global das parteiras.

Glossário Essencial

Os termos mais importantes deste Livebook, para consulta rápida.

Termo	Significado
Reforma Obstétrica	Proposta de mudar quem coordena o cuidado ao parto no Brasil.
Enfermeira Obstétrica	Enfermeira com especialização em obstetrícia, habilitada a assistir partos de risco habitual.
Obstetriz	Profissional formada em curso de graduação específico de Obstetrícia.

A Reforma Obstétrica no Brasil

Luciane da Silva D'Avila · SIAPARTO · São Paulo / SP · 2025

Termo	Significado
ABENFO	Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras.
Mortalidade Materna	Mortes de mulheres durante a gestação, parto ou até 42 dias após o parto.
Risco Habitual	Gestações sem complicações graves — cerca de 85% dos partos segundo a OMS.
Modelo Hospitalocêntrico	Modelo em que o hospital é o centro do cuidado, com forte protagonismo médico.
Centro de Parto Normal (CPN)	Estabelecimento dedicado ao parto fisiológico, liderado por enfermeiras obstétricas.
Rede Cegonha / Rede Alyne	Políticas públicas brasileiras (2011 e 2024) para qualificar a atenção ao parto.